

Activité du patient dans la psychanalyse

« [La] psychanalyse n'est pas une opération extérieure qui serait conduite par un tiers sur un objet passif et docile. On ne se fait pas analyser comme on peut se faire coiffer, maquiller ou habiller, en restant immobile. L'emploi du passif est maladroit : il serait plus exact de dire qu'on est en analyse. Certes, il y a un psychanalyste, mais il y a aussi un patient. On a parlé d'« analysé », mais certains ont préféré le terme d'« analysant », afin d'insister sur le caractère actif de celui qui fait une psychanalyse : celui-ci ne vient pas recevoir de son analyste un contenu d'informations et de théories, dont la simple communication suffirait à résoudre son mal-être et ses problèmes. Il ne vient pas à un cours magistral, où seraient enseignées les différentes théories psychanalytiques. Il engage, grâce à l'aide de son analyste et grâce à la situation analytique, au « cadre », un travail sur soi, que lui seul peut mener. Il va être en quelque sorte l'acteur de sa cure, car lui seul est en possession du matériau de ce travail, lui seul peut se remémorer. La présence de l'analyste, ses questions, ses silences, ses propositions d'interprétation sont certes indispensables. Il n'est guère possible de faire tout seul chez soi — ou très imparfaitement et très partiellement — une psychanalyse. C'est bien parce que les gens ont le sentiment de ne pas parvenir à se sortir seuls de leurs difficultés psychologiques, qu'ils vont quérir de l'aide auprès d'un analyste. Mais cela ne veut pas dire que la solution vienne de lui. Freud souligne d'ailleurs que le patient doit venir lui-même à la conscience de ce qu'il refoule. L'[analyste] peut bien avoir saisi depuis longtemps ce qui se passe, comment son patient fonctionne et quels mécanismes psychiques sont en jeu dans sa névrose. Si l'analyste n'est pas passif et cherche des interprétations, la difficulté est alors pour lui de trouver le moment opportun pour s'en ouvrir à son patient :

« – Quand vous avez trouvé les bonnes interprétations, une nouvelle tâche s'impose. Il vous faut attendre le bon moment pour communiquer votre interprétation au patient avec quelque perspective de succès.

– À quoi reconnaît-on chaque fois le bon moment ?

– C'est une question de flair, un flair qui peut être considérablement affiné par l'expérience. Vous commettez une faute grave si, par exemple, dans vos efforts pour abréger l'analyse, vous jetez vos interprétations à la tête du patient dès que vous les avez trouvées. Vous obtenez par là, chez lui, des manifestations de résistance, de récusation, d'indignation, mais vous ne parvenez pas à ce que son moi s'empare du refoulé. Le précepte, c'est d'attendre qu'il s'en soit suffisamment approché pour que, sous la conduite de l'interprétation que vous proposez, il n'ait plus que quelques pas à faire¹. »

Celui qui entreprend une analyse n'est donc pas passif mais acteur de son analyse. Il n'est pas docile non plus. Freud dit ici qu'il développe des résistances : il résiste à la reconnaissance du refoulé. Il est venu trouver l'analyse pour aller mieux, mais le traitement n'a rien d'automatique, si bien que Freud peut dire du patient « qu'il ne veut absolument pas recouvrer la santé². L'analyse doit en effet l'aider, dans la mesure du possible, à vaincre les résistances que celui-ci oppose au progrès de sa cure, et à renoncer aux bénéfices secondaires que lui procurait son état de maladie. »

→ Claire Pagès, *Freud pas à pas* (2008), p.16.

¹ « La question de l'analyse profane. Entretiens avec un homme impartial », 1926, p. 1-92, in Freud, *Œuvres complètes*, Psychanalyse, XVIII, 1926-1930, [...] p.45.

² *Ibid.*